

Brain & Mind

Hot Issue

치매관리주치의 시범사업에 관하여
최호진 / 한양대학교 구리병원

치매관리주치의 시범사업에 관하여

배경

2023년 12월 29일, 보건복지부에서 “치매관리주치의 시범사업” 참여 의사 및 기관 공모가 시작된 이후 많은 분들이 이번 시범사업에 대해서 궁금해하고 있다.

이번 글에서는 치매관리주치의 시범사업의 실시 배경과 구체적인 제도에 대해서 안내드리고자 한다. 이번 시범사업은 치매 환자 관리를 위해서 다양한 정책 대안을 논의하는 자리인 치매정책발전협의체에서 처음 제시되었다. 2021년 12월 회의에서 제안된 이후 보건복지부에서 중점 추진 사업으로 선정하였다. 시범사업 모델 개발을 위해서 2022년에 본 원고 집필자가 연구 책임자를 담당하고, 치매 분야 전문 의료진을 중심으로 “치매안심주치의 운영 모델 개발 연구”를 진행하였고, 연구 결과를 바탕으로 치매 분야 전문가들과 보건복지부, 중앙치매센

터 담당자들과 지속적인 논의 끝에 이번 치매관리주치의 시범사업이 결정되었다.

시범사업의 개요

치매 환자가 지역 사회에 거주하면서 치매 관리에 전문성 있는 의사(치매관리주치의)를 통해 치매와 그 외 건강 문제까지 꾸준히 치료·관리하여 건강 및 삶의 질을 유지·증진시킬 수 있는 의료체계를 구축하고자 하는 목적으로 시행된다. 시범사업은 2024년 2월 29일까지 진행될 공모를 통해서 대상 지역 및 참여 의사(의료기관)를 선정하고, 시범사업 관련 교육 등을 거쳐 내년 7월부터 2026년 6월까지 2년간 진행될 예정이다. 사업 대상자는 치매를 진단받은 환자이며 입원 환자는 제외된다. 대상 기관은 신청 기관이 모두 참여하는 것이 아니고, 첫 시범사업인 점을 고려하여 지역

별 배분과 참여 의료진 수를 고려하여 시·군·구 단위로 20개 지역을 선정하여 진행할 예정이다. 대상 의사는 신경과 또는 정신건강의학과 전문의 혹은 치매전문교육 이수 의사로 한정된다. 이번 시범사업을 통해서 받게 되는 서비스는 다음 단원에서 좀 더 자세히 설명드리겠다.

치매 관리 서비스

이번 시범사업을 통해서 진행하는 치매 관리 서비스는 크게 2가지로 구분된다. 일반 건강 관리와 함께 치매증상을 관리 받는 통합 관리와 치매증상만을 전문적으로 관리 받는 치매 전문 관리로 구분되어서 진행하며 이는 환자(보호자)가 선택할 수 있다. 서비스 개요는 <그림 1>과 같다. 통합 관리는 치매 관리와 함께 관련 치료·관리 서비스와 만성 질환 관리 등 일반 건강 관

구분	통합 관리(일반 건강 관리 + 치매 전문 관리)	치매 전문 관리
대상자	치매 환자	
치매관리주치의	신경과 또는 정신건강의학과 전문의, 치매전문교육 이수 의사	
서비스 제공 의료기관	일차 의료 만성 질환 관리 시범사업 참여 의원 ¹	의원, 치매안심센터 협약 또는 광역치매센터 운영 병원/종합병원 *광역치매센터 운영 상급종합병원 포함
서비스 내용	· 치매 심층 교육/상담 · 방문 진료(의원만 해당) ² · 만성 질환 등 일반 건강 관리(통합 관리 시)	
	· (환자 관리) 복약/약물 부작용, 합병증 발생 여부 확인 등 관리 · (연계 서비스) 치매안심센터 연계, 진료 의뢰-회송 등	

그림 1. 치매 관리 서비스 개요

¹ 통합 관리는 일차 의료 만성 질환 관리 시범사업 참여 의원에서 실시

² '의료전달체계' 및 현재 시행 중인 '일차 의료 방문 진료 시범사업'을 고려하여 '의원'에서 실시

리를 함께 받고자 하는 치매 환자를 대상으로 진행한다. 치매 진료 시 고혈압·당뇨병 등 만성 질환이나 전반적 건강 문제를 진료, 검사 및 검사 결과 분석, 다제 약물 관리 등을 포함한다. 또한 환자 상황에 따라 관련 생활습관 등 교육·상담도 이루어진다. 통합 관리를 담당하기 위해서는 본 사업의 참여 의사 요건과 함께 일차 의료 만성 질환 관리 시범사업 참여 의원이어야 한다. 치매 전문 관리는 치매 관련 치료·관리 서비스를 집중적으로 받고자 하는 치매 환자를 대상으로 하며 치매 환자 및 보호자 대상 심층 교육·상담, 증상(BPSD 등) 수준 및 환자 상황(거동 불편 등)에 따라 방문 진료(의원급 한정)도 하게 된다. 이를 위해서 관리와 상담을 진행하기 위한 치료 관리 계획이 필요하다.

서비스 연계

서비스 제공 과정에서 서비스 연계가 필요하다고 판단되면 치매 관리 주치의는 치매안심센터와 협력하여 간호사, 사회복지

사 등과 팀을 구성하여 방문 진료를 실시할 수 있다. 이는 치매 환자가 질환 문제뿐만 아니라 주거 여건 등 의료진의 힘만으로 해결하기 힘든 공공복지 관련 문제도 함께 가지고 있는 경우가 많기 때문이다.

또한 이 과정에서 돌봄 등 서비스 및 지역사회 자원 연계를 진행할 수 있다. 그리고 치매 관리 주치의가 치매 환자의 상태가 위중하여 집중 치료, 정밀 검사 등이 필요한 경우 상급의료기관(상급종합병원, 종합병원, 전문병원)으로 의뢰할 수 있으며, 의뢰받은 상급의료기관은 치료 후 치매 관리 주치의에게 환자를 회송하도록 되어 있다.

시범사업 수가

이번 시범사업의 경우 이전에 유사한 시범사업들이 다수 있었던 관계로 기존 사업에 준해서 수가가 결정되었다.

치매 관리 수가, 치매 교육 상담료가 신설된 점과 치매 환자의 특성을 고려하여 비대면 관리 수가가 책정된 점은 고무적이지만, 많은 노력을 기울여야 하는 치매 진

료 현장에서 볼 때 시범사업 수가가 다소 미흡하다고 생각할 수 있다. 이번 시범사업 건강보험 요양 급여비용안은 <그림 3>과 같다.

마치며

치매 안심 주치의 운영 모델 개발 연구를 담당했던 전문가의 입장에서 이번 시범사업의 시작은 치매 환자를 위해서 새로운 제도가 시행된다는 기대감과 함께 전문가 의견 반영이 만족스럽지 못했다는 아쉬움이 교차한다. 치매 안심 주치의 운영 모델 개발 연구에서는 기존 치매 환자를 돌보는 일차 의료기관에 영향을 줄일 수 있도록 현행 의료 시스템에서 소외되는 환자들에 대한 접근성을 중점으로 두고 제도를 설계해서 독거 노인, 경제적, 의학적 문제로 의료기관 방문이 힘든 분들을 대상으로 선정하고자 하였고, 치매안심센터와 치매안심병원의 공공의료 체계를 이용, 방문 진료와 비대면 진료를 결합하여 참여 의료기관의 수가를 높일 수 있는 방안

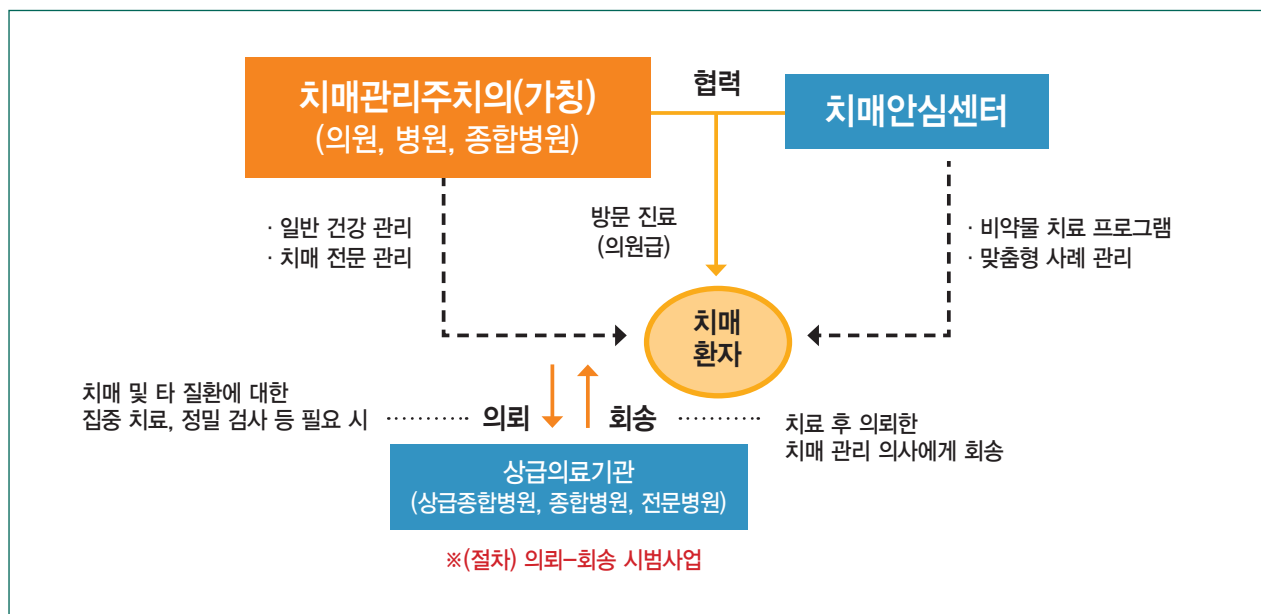


그림 2. 치매관리주치의 서비스 연계 제공 모형

※진료 의뢰·회송 절차는 협력기관 간 진료 의뢰·회송 시범사업(2016년 5월~)에 따름

분류	금액(원)*	급여 횟수	비고
치매 관리료			
1. 포괄평가 및 계획수립료		연 1회	
가. 의원	48,480		치매 전문 관리 수가 통합 관리 시 치매 전문 관리에 가산되는 수가,
주. 만성 질환 또는 전반적 건강 관리를 함께 실시한 경우 별도 산정	14,540		일차 의료 만성 질환 관리 시범사업 참여 의원만 산정
나. 병원, 정신병원, 요양병원, 종합병원, 상급종합병원	48,480		
2. 중간 점검료		연 1회	
가. 의원	27,060		치매 전문 관리 수가 통합 관리 시 치매 전문 관리에 가산되는 수가,
주. 만성 질환 또는 전반적 건강 관리를 함께 실시한 경우 별도 산정	8,120		일차 의료 만성 질환 관리 시범사업 참여 의원만 산정
나. 병원, 정신병원, 요양병원, 종합병원, 상급종합병원	27,060		
3. 환자 관리료		연 12회 이내 (월 1회 이내)	비대면(관리 O, 진료 X)
가. 의원	10,310		
나. 병원, 정신병원, 요양병원, 종합병원, 상급종합병원	10,310		
4. 교육/상담료		연 8회 이내	대면
가. 의원	15,120		
나. 병원, 정신병원, 요양병원, 종합병원, 상급종합병원	15,120		10분 이상
5. 방문 진료료		연 4회 이내	의원급만 산정
가. 방문 진료료 I_의원	126,900		행위/약제 및 치료 재료 등에 대한 비용을 포함(행위/약제 및 치료 재료 등 수가 별도 산정 불가)
나. 방문 진료료 II_의원	88,280		행위/약제 및 치료 재료 등에 대한 비용을 포함하지 않음(행위/약제 및 치료 재료 등 수가 별도 산정 가능)

그림 3. 치매관리주치의 시범사업 건강보험 요양 급여비용안
※2023년도 의원급 단가, 병원급 단가 적용된 금액임

고민도 하였다. 결국 구체적인 실행안을 두고 논의하는 과정에서 시범사업의 진행을 위해서 불가피하게 기존 사업과 유사한 형태로 수정되었지만 치매 관리 분야에서 의 국가 정책 의사 결정에서 보건 분야의 중요성을 확인하고 치매 관리 사업의 확대를 위하여 적극적으로 참여하고자 하였다.

환자의 관리 항목과 방법 등에서 진료 현장의 눈높이에 아직 부족할 수 있으나 기존 의료시스템에 소외되기 쉬운 치매 환자들을 위한 제도가 처음 시행되는 만큼, 향후 본 사업이 지속적으로 발전하고 개선

되기 위해서는 치매 전문가들의 적극적인 참여가 필요하다고 생각한다.

치매관리주치의 시범사업에 대한 많은 분들의 참여와 관심을 부탁드립니다. 이 글을 마친다.



“치매관리주치의
시범사업 참여 의사
(의료기관)” 공모